

Lymphome de Hodgkin

Aperçu

Le lymphome de Hodgkin est un type de cancer qui prend naissance dans le système lymphatique, une partie du système immunitaire de l'organisme. Il se caractérise par la présence de cellules de Reed-Sternberg, qui sont des cellules de grande taille avec des noyaux bilobés, visibles au microscope.

Étiologie

La cause exacte du **lymphome de Hodgkin** est inconnue, mais certains **facteurs de risque** incluent :

- ❑ **Infections virales** : notamment le **virus d'Epstein-Barr (EBV)**.
- ❑ **Antécédents familiaux** : une **histoire familiale** de lymphome de Hodgkin peut augmenter le risque.
- ❑ **Âge** : il est plus fréquent chez les jeunes adultes (**15-30 ans**) et les personnes âgées (**> 55 ans**).
- ❑ **Sexe** : les **hommes** sont légèrement plus susceptibles de développer cette maladie que les femmes.

Types

Le lymphome de Hodgkin est classé en deux principaux types :

1. **Lymphome de Hodgkin classique** (95% des cas)
 - **Sclérose nodulaire** : la forme **la plus courante**, avec des bandes de tissu cicatriciel. Surtout les **jeunes**, bon pronostic.
 - **Cellularité mixte** : caractérisé par une diversité de cellules. Plus **âgé**, moins bon pronostic.
 - **Riche en lymphocytes** : un grand nombre de lymphocytes présents.
 - **Déplétion lymphocytaire** : rares lymphocytes, souvent agressif.
2. **Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire** (5% des cas)
 - Caractérisé par des cellules pop-corn (des variantes des cellules de Reed-Sternberg).

Symptômes

- ❑ **Adénopathies indolores**, typiquement **cervicales**, **supraclaviculaire** et/ou **médiastinales**.
- ❑ **Symptômes B** : **fièvre intermittente** (cycle de 1-2 semaines), sueurs nocturnes, perte de poids inexpliquée.
- ❑ **Prurit** : démangeaisons généralisées.
- ❑ **Fatigue** : sensation de fatigue persistante.
- ❑ **Douleur après consommation d'alcool** : bien que rare, la **douleur dans les ganglions lymphatiques après avoir bu de l'alcool** est un symptôme spécifique.

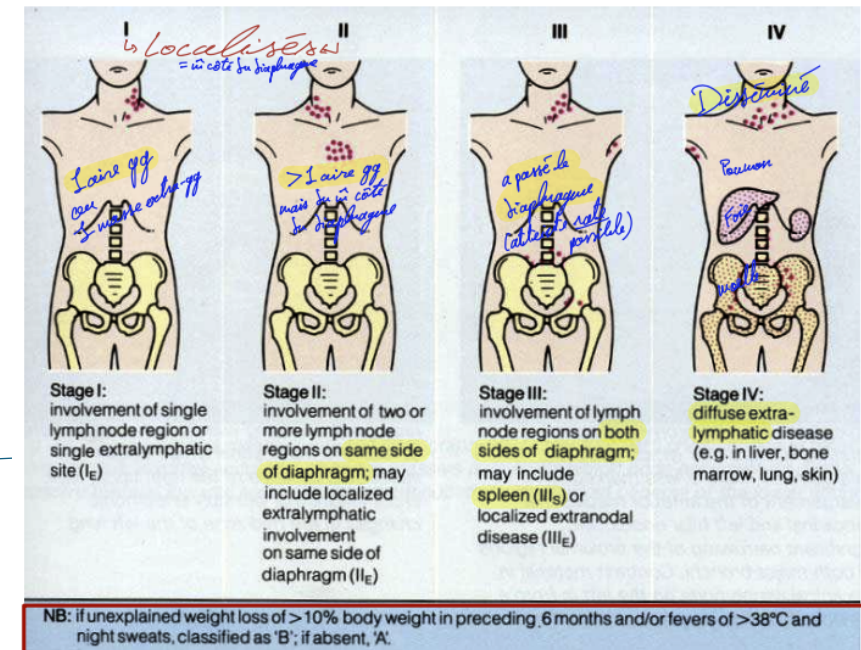
Diagnostic

- ❑ **Biopsie ganglionnaire** : examen histopathologique pour identifier les **cellules de Reed-Sternberg**.
- ❑ **Tests d'imagerie** : **CT**, **PET-Gallium** pour évaluer l'étendue de la maladie.
- ❑ **Analyses sanguines** : pour vérifier la fonction des organes et les marqueurs de la maladie.
- ❑ **Pronostic** : Bon, taux de survie à 5 ans d'environ 80 à 90 % (> 95 % chez les enfants)

Stades

Staging des lymphomes selon Ann Arbor

Actualisation 2014 "Lugano staging" basée sur PET-FDG



A = $\emptyset$ Symptômes B
B = Symptômes B

Le lymphome de Hodgkin est classé en quatre stades de **Ann Arbor/Lugano**:

1. **Stade I** : un seul groupe de ganglions lymphatiques affecté.
2. **Stade II** : deux groupes de ganglions lymphatiques ou plus du même côté du diaphragme.
3. **Stade III** : ganglions lymphatiques des deux côtés du diaphragme.
4. **Stade IV** : dissémination à d'autres organes comme le foie ou la moelle osseuse.

A = Absence de symptômes **B**

B = Symptômes **B**

Traitement

Le traitement dépend du stade et du type de **lymphome de Hodgkin**, ainsi que de l'état de santé général du patient :

- ❓ **Chimiothérapie** : régime **ABVD** (*adriamycine, bléomycine, vinblastine, dacarbazine*) est souvent utilisé.
- ❓ **Radiothérapie** : souvent combinée avec la chimiothérapie pour les stades précoces.
- ❓ **Immunothérapie** : comme les inhibiteurs de points de contrôle pour les cas réfractaires.
- ❓ **Greffe de cellules souches** : utilisée dans les cas récurrents ou réfractaires.

Pronostic

Le lymphome de Hodgkin a un pronostic relativement bon, surtout s'il est diagnostiqué à un stade précoce. Le taux de survie à cinq ans varie en fonction du stade de la maladie, avec des taux de survie élevés pour les stades I et II.

Lymphomes Non-Hodgkiniens (LNH)

Les lymphomes non-hodgkiniens regroupent une variété de cancers affectant les cellules lymphocytaires. Contrairement au lymphome de Hodgkin, ils ne présentent pas de cellules de Reed-Sternberg. Voici un résumé détaillé des caractéristiques communes et spécifiques des principaux types de LNH.

Caractéristiques communes

- ? **Étiologie** : translocations chromosomiques, infections (EBV, HIV, HTLV-1, H. pylori), maladies auto-immunes (Hashimoto, polyarthrite rhumatoïde, Sjögren), immunodéficience, facteurs environnementaux (hydrocarbures aromatiques, radiations).
- ? **Distribution** : touche plusieurs groupes ganglionnaires de manière non contiguë, atteinte fréquente des sites extranodaux.
- ? **Symptômes** : **adénopathie indolore, fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids inexpliquée, fatigue, prurit**.
- ? **Diagnostic** : Attention : Pas de ponction à l'aiguille fine ? **biopsie ganglionnaire**, tests d'imagerie (**CT cou-thorax-abdomen**, **PET-CT 18 FDG**), Ponction-biopsie de moelle.
- ? **Traitement** : chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, greffe de cellules souches.
- ? **Pronostic général** :
 - ? **Lymphomes de haut grade** : survie de plusieurs mois à quelques années pour les variantes moins agressives.
 - ? **Lymphomes de bas grade** : survie médiane de 6-10 ans.
 - ? Indicateurs de mauvais pronostic : **âge avancé, nombre de sites nodaux et extranodaux impliqués, ↑ LDH, ↑ β2-microglobuline** = reflet de la masse tumorale.

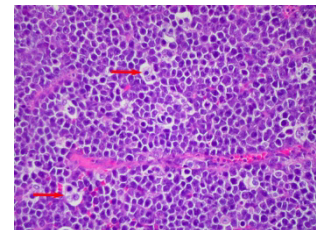
Lymphomes B agressifs :

Lymphome B à grandes cellules diffus (DLBCL)

- ? **Fréquence** : le type **le plus courant** de LNH.
- ? **Étiologie** : mutations dans les gènes **Bcl-2**, Bcl-6 et p53.
- ? **Histologie** : cellules B larges avec des noyaux vésiculaires et un cytoplasme abondant, mitoses fréquentes.
- ? **Présentation** : **croissance rapide de ganglions lymphatiques, atteinte extranodale** fréquente (tractus gastro-intestinal, cerveau).
- ? **Traitement** : chimiothérapie combinée (**R-CHOP** : rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisone).
- ? **Pronostic** : taux de survie à 5 ans d'environ 60-70 %.

Lymphome de Burkitt **MYC**

- ? **Fréquence** : **rare mais très agressif**.
- ? **Étiologie** : souvent associé à l'infection par le **virus d'Epstein-Barr (EBV)** et caractérisé par une translocation **t(8;14)** ? **surexpression de MYC**
- ? **Histologie** : modèle en "**ciel étoilé**" avec des macrophages contenant des débris cellulaires entourés de cellules tumorales uniformes.
- ? **Présentation** : **masse abdominale ou tumeur des mâchoires** (forme endémique en Afrique), **atteinte rapide du SNC**.
- ? **Traitement** : **chimiothérapie intensive** (CODOX-M/IVAC).
- ? **Pronostic** : bon si traitement précoce, taux de survie à 5 ans de 80-90 %.



Lymphome primaire du médiastin

- ? **Étiologie** : origine incertaine, souvent observé chez les **jeunes femmes**, absence de translocations typiques des autres lymphomes B.
- ? **Histologie** : cellules B larges avec une grande variabilité morphologique, souvent associées à une sclérose fibreuse.
- ? **Présentation** : **masse médiastinale volumineuse, dyspnée, toux, douleurs thoraciques, syndrome de la veine cave supérieure**.
- ? **Traitement** : chimiothérapie combinée (**R-CHOP**) souvent suivie de radiothérapie.
- ? **Pronostic** : taux de survie à 5 ans d'environ 70-85 %.

Lymphomes B indolents :

Lymphome folliculaire **Bcl-2**

- ? **Fréquence** : lymphome de **bas grade le plus courant** chez les adultes.
- ? **Étiologie** : translocation **t(14;18)** impliquant le gène **Bcl-2**.
- ? **Histologie** : cellules centrocytiques avec des noyaux encochés, disposition nodulaire.
- ? **Présentation** : **croissance lente**, **adénopathie généralisée indolore**, souvent **asymptomatique** pendant des années.
- ? **Traitement** : observation (pour les stades précoces et asymptomatiques), immunothérapie (**rituximab**), chimiothérapie.
- ? **Pronostic** : survie médiane de 10 à 15 ans, certains patients vivent plus longtemps.

Leucémie lymphocytaire chronique (LLC)

- ? **Fréquence** : type le plus courant de leucémie chez l'adulte.
- ? **Étiologie** : anomalies génétiques variées, souvent des délétions chromosomiques.
- ? **Histologie** : petites cellules lymphocytaires matures dans le sang périphérique et la moelle osseuse, **Ombre de Gumprecht**.
- ? **Présentation** : **adénopathie généralisée**, **hépatosplénomégalie**, **cytopénies** et **Lymphocytose > 5 G/L persistante**, **infections récurrentes**.
- ? **Traitement** : **observation** (stades précoces), **inhibiteurs de la tyrosine kinase (imatinib)**, immunochimiothérapie (FCR : fludarabine, cyclophosphamide, rituximab).
- ? **Pronostic** : survie médiane de 8 à 10 ans, dépend fortement de la présence de mutations génétiques spécifiques.

Lymphome de la zone marginale MALT

- ? **Étiologie** : infections chroniques, notamment **H. pylori** pour les lymphomes gastriques, et **maladies auto-immunes**.
- ? **Histologie** : petites cellules B avec des noyaux irréguliers, infiltration de la muqueuse gastrique.
- ? **Présentation** : dépend de l'organe affecté (**dyspepsie** pour le MALT gastrique).
- ? **Traitement** : **éradication** de l'infection sous-jacente (antibiotiques pour H. pylori), radiothérapie locale, immunothérapie (**rituximab**).
- ? **Pronostic** : bon, taux de survie à 5 ans de 80-90 % avec un traitement adéquat.

Lymphomes B à part :

Lymphome du manteau

- ? **Fréquence** : rare et souvent diagnostiqué à un stade avancé.
- ? **Étiologie** : translocation **t(11;14)** impliquant le gène **cycline D1**.
- ? **Histologie** : petites cellules lymphocytaires avec des noyaux irréguliers, disposition nodulaire ou diffuse.
- ? **Présentation** : **adénopathie généralisée**, **hépatosplénomégalie**, **atteinte gastro-intestinale**.
- ? **Traitement** : chimiothérapie intensive, immunothérapie, greffe de cellules souches.
- ? **Pronostic** : mauvais, taux de survie médian de 3 à 5 ans.